一、糖尿病患者用药指导

仔细阅读住院期间护士给您的疾病宣教单

常见的口服降糖药服药时间及副作用

要积极治疗，短期用胰岛素

医生，我血糖很高怎么办?

1、磺酰脲类促泌剂—达美康、亚莫利

服药时间:餐前半小时

副作用:

(1)使用不当可导致低血糖，特别是老年病友、肝肾功能不全。

(2)体重增加。

2、非磺酰脲类胰岛素促分泌剂(格列奈类)—诺和龙

服药时间:餐前 15-30 分钟，进餐服药，不进餐不服药。

副作用:低血糖和体重增加，但低血糖风险和程度较磺脲类轻。

3、DPP4 酶抑制剂—捷诺维、安立泽、佳维乐

服药时间:不受进餐影响，餐前餐后均可。

副作用:胃肠道不良反应，如恶心，程度多由轻到中度，主要见于刚开始治疗时，随治疗时间延长逐渐减少。

4、双胍类—格华止

服药时间:餐时或餐后半小时。

副作用:胃肠道反应，如腹胀、腹泻、恶心等。

5、胰岛素增敏剂—卡司平

服药时间:与进食无关。

副作用:体重增加和水肿，尤其是与胰岛素联用时更加明显。

6、葡萄糖苷酶抑制剂—拜糖平、卡博平

服药时间:与第一口饭一起嚼服。

副作用:胃肠道反应，如腹胀、排气。

GLP-1 受体激动剂

1、艾塞那肽—百泌达

注射时间:早/晚餐前 1h 皮下注射，或中/晚餐前 1h 皮下注射，两餐间隔 6h

以上。

副作用:胃肠道不良反应，如恶心，呕吐，程度多由轻到中度，见于治疗初期，随治疗时间延长而逐渐减轻。

2、利拉鲁脑—诺和力

注射时间:皮下注射，与进餐无关。

副作用:胃肠道不良反应，如恶心，呕吐，程度多由轻到中度，见于治疗初期，随治疗时间延长而逐渐减轻。

<TABLE1>糖尿病注射胰岛素及类似物的种类及作用

下面介绍不同种类胰岛素的用法：

按作用特点分类，

餐时胰岛素

基础胰岛素

预混胰岛素

胰岛素制剂

餐时胰岛素

短效人胰岛素(诺和灵 R)

速效胰岛素类似物(诺和锐、优泌乐)

短效动物胰岛素(普通胰岛素)

基础胰岛素

长效胰岛素(诺和平)

中效人胰岛素(诺和灵 N)

长效胰岛素类似物(来得时)

预混胰岛素

预混人胰岛素(诺和灵 30R、诺和灵 50R)

预混胰岛素类似物(诺和锐 30、诺和锐 50、优泌乐 25)

注射时间

餐时胰岛素

短效人胰岛素(诺和灵 R)　餐前 30 分钟

速效胰岛素类似物(诺和锐、优泌乐) 餐前即刻

短效动物胰岛素(普通胰岛素) 餐前 30 分钟

基础胰岛素

长效胰岛素(诺和平) 睡前

中效人胰岛素(诺和灵 N) 睡前

长效胰岛素类似物(来得时) 每天固定同一时间

预混胰岛素

预混人胰岛素(诺和灵 30R、诺和灵 50R) 餐前 30min

预混胰岛素类似物(诺和锐 30、诺和锐 50、优泌乐 25) 餐前即刻

<TABLE1>糖尿病注射胰岛素及类似物的种类及作用

下面介绍不同种类胰岛素的用法：**糖尿病注射胰岛素及类似物的种类按照作用特点可以分为**餐时胰岛素、基础胰岛素和预混胰岛素。其中，**餐时胰岛素的胰岛素制剂包括：**短效人胰岛素(诺和灵 R)、速效胰岛素类似物(诺和锐、优泌乐)、短效动物胰岛素(普通胰岛素)；**基础胰岛素的糖尿病注射胰岛素及类似物的种类包括：**长效胰岛素(诺和平)、中效人胰岛素(诺和灵 N)、长效胰岛素类似物(来得时)；**预混胰岛素的糖尿病注射胰岛素及类似物的种类包括：**预混人胰岛素(诺和灵 30R、诺和灵 50R)、预混胰岛素类似物(诺和锐 30、诺和锐 50、优泌乐 25)。**不同种类胰岛素的注射时间如下，**短效人胰岛素(诺和灵 R) 餐前 30 分钟；速效胰岛素类似物(诺和锐、优泌乐) 餐前即刻；短效动物胰岛素(普通胰岛素) 餐前 30 分钟；长效胰岛素(诺和平) 睡前；中效人胰岛素(诺和灵 N) 睡前；长效胰岛素类似物(来得时) 每天固定同一时间；预混人胰岛素(诺和灵 30R、诺和灵 50R) 餐前 30min；预混胰岛素类似物(诺和锐 30、诺和锐 50、优泌乐 25) 餐前即刻。

<TABLE2>胰岛素注射技术

注意不同注射部位之间的轮换，在任何部位注射时，与上次注射点在 1cm 以上。

胰岛素种类

超短效胰岛素注射部位：任何部位

短效胰岛素注射部位：腹部

中效胰岛素注射部位：臀部或者大腿

预混胰岛素注射部位：早餐前:腹部晚餐前:臀部或大腿

<TABLE2>胰岛素注射技术

注意不同注射部位之间的轮换，在任何部位注射时，与上次注射点在 1cm 以上。按照不同的胰岛素种类，有不同的注射部位。超短效胰岛素注射部位：任何部位；短效胰岛素注射部位：腹部；中效胰岛素注射部位：臀部或者大腿；预混胰岛素注射部位：早餐前:腹部晚餐前:臀部或大腿。

注射胰岛素后药物不良反应及观察要点

脂肪萎缩：经常更换注射部位或使用高纯度的胰岛素可以防止其发生。

过敏：局部过敏仅为注射部位及周围出现斑丘疹，瘙痒。全身过敏可引起荨麻疹，极少数严重者可出现过敏性休克。

皮下脂肪增生：每天多次在相同部位注射胰岛素的患者较常发生，且大多位于腹部。注射在脂肪增生部位，常会造成皮下胰岛素的吸收变化。

视力模糊：属暂时性变化，一般随血糖浓度恢复正常而迅速消失，不致发生永久性改变，故不必配镜矫正，一般无需处理。

低血糖：患者要随身携带糖果、甜点等食品，以便在出现低血糖反应时能及时进行自我救治。

体重增加：使用胰岛素后，过多的葡萄糖转变成脂肪贮存在体内，引起体重增加。或者当开始胰岛素治疗时，有的患者害怕会发生低血糖，因此，多吃一些食物来防御，也会影响体重。

二、糖尿病患者饮食指导：

仔细阅读住院期间护士给您的疾病宣教单

糖尿病饮食治疗目标：

1.维持合理体重

2.提供均衡营养膳食

3.控制血糖

4.减少心血管疾病危险因素

5.恢复胰岛功能

糖尿病患者科学饮食原则：

1.控制一日总热量，保持“收支”平衡。

2.均衡营养，粗细搭配:三大营养素合理搭配:碳水化合物 50%~60%，脂肪不超过 30%，蛋白质 15%~20%。

3.食物称重量，定时定量进餐。

4.少食多餐，合理配餐，谷薯类，果蔬类，肉蛋类，油脂类缺一不可。

5.高膳食纤维饮食，维持体重，帮助通便 6.低盐、低脂、低油、低糖、清淡饮食。

6.低盐、低脂、低油、低糖、清淡饮食。

吃动两平衡：管住嘴，迈开腿。万一哪一顿不小心吃多了，坚持运动消耗多余的热量，确忌盲目自行增加药量！

巧用食物量具

食品称

食物量具

手掌法则:使用自己的手掌做测量工具

1.碳水化合物：2 个拳头。根据自己拳头大小选择一顿所需吃主食量（碳水化合物需求量）例如馒头、花卷、米饭等。水果一天需要量则相当于 1 个拳头大小。

2.蛋白质：1 个掌心。50 克的蛋白质相当于掌心大小、约为小指厚的一块。每天吃 50-100 克的蛋白质即可满足一天需求。

3.蔬菜：两手抓，两只手能够抓住的菜量(1 把)可相当于 500 克的量，每天进食 500 至 1000 克蔬菜可满足需要。当然这些蔬菜都是低碳水化合物蔬菜如绿豆、豆芽、卷心菜等。

4.脂肪：一个拇指尖。要限制脂肪(黄油)的摄入，每天仅取拇指的尖端（第

批注 [文陈1]: 国外饮食结构，不符合国内饮食结构建议。

一节)就足够。

5.瘦肉量：一指厚两指宽，切一块与食指厚度相同，与两指（食指和中指并拢）的长度、宽度相同的瘦肉相当于 50 克的量，即可满足一天需要。

餐盘法则:

一般情况下使用 15.7 厘米的餐盘，1/4 放主食+1/4 放蛋白+1/2 放蔬菜。

在家用油好方法

用带刻度透明小量杯取 10ml 油或用普通汤匙装 1 勺油做一道菜，每人每日用油量不超过 25ml 或 2.5 勺。

烹调方法很重要

推荐方法：炖、清蒸、烩、凉拌、煮、汆、煲。对营养成分损失少，不增加脂肪容易消化吸收，清淡爽口。

不推荐方法：炸，煎，红烧。对蛋白质、维生素破坏多，肉中脂肪过度氧化，产生致癌物，增加脂肪和热量。

增加饱腹感小窍门

1.餐前饮用一杯白水。

2.用餐时先吃完蔬菜，然后再吃主食和鱼肉。

类中

3.用餐过程持续 20 分钟，细嚼慢咽。

4.餐中根据需要增加饮水量。

5.餐后尽快转移注意力。

饮酒注意事项

1.每次饮酒量以 1~2 个酒精单位为限。

2.一个酒精单位约含 90 千卡的热量，大约相当于啤酒(含 4%酒精)400ml，红酒(含 10%酒精)150ml，或 30 度白酒 50m1。每周饮酒量不超过 2 次，高度烈性白酒应当禁饮。

3.饮酒前应吃些富含碳水化合物的主食，严禁在空腹和睡前饮酒。

外出用餐注意事项

1.使用胰岛素者，应严格按胰岛素起效时间就餐。使用速效胰岛素者，应等食物上桌后再注射，以免注射过早诱发低血糖。

2.将菜在白开水里涮一涮再吃，减少油脂摄入。

3.尽量不吃自助餐。

4.进食土豆、红薯和山药等淀粉含量高的食物不要超过自己拳头大小，从主食中等量扣减。

5.甜味剂可以分为无热量（非营养型）和有热量（营养型）。无热量型：阿司巴甜、糖精等；有热量型: 果糖、山梨醇、甘露醇、木糖醇；代糖并不代表无热能，每克木糖醇产热 3.5 千卡，谨慎食用。

生病了怎么办：

如果出现发热，呕吐，腹泻不能进食者，暂时停用降糖药并立即就医。

出现低血糖怎么办：

如血糖≤3.9mmol/l 或出现了心慌、出冷汗、饥饿感等，则可能出现了低血糖。出现低血糖时，应立即进食含糖的饮料或食物，如有条件可先检测血糖，随后吃含“15g”的葡萄糖饮料或食物如 2~5 个葡萄糖片、半杯桔子汁、两大块方糖、一大汤勺的蜂蜜等，15 分钟后您需再次测量血糖，如果血糖<4mmmol/l 时，您还需吃“15g”的葡萄糖饮料或食物。如您的低血糖发生在午夜或离下一餐还有 1 小时，还需吃含“25g”的碳水化合物的食品。多次出现低血糖请及时就诊。

控制饮食常见误区解答

误区一：只要用了药，饭菜随便吃。

解答：糖尿病患者每日总热量要均衡分配，严格遵医嘱用药，不可随意加减药。

误区二：不吃主食，血糖就不会升高。

解答：一定要吃主食，主食含有丰富的 B 族维生素，可以防治并发症，同时是最经济的热量来源。

误区三：糖尿病患者不能吃水果。

解答：水果中的维生素、矿物质和纤维素对糖尿病患者有益处，而果糖的代谢不需要胰岛素且有延缓葡萄糖吸收的作用，血糖控制达标者可以吃水果，建议两餐之间吃。

误区四：糖尿病患者不能喝粥

解答：可以喝粥。建议熬粥时间不要太长，在粥变稠前喝以防快速生血糖；

加入青菜、杂粮，适当减少大米的分量；不要只喝粥，同时辅以青菜，肉类，可以延缓粥代谢时间，降低对血糖的影响。

误区五：无糖食品可以随便吃。

解答：除了白开水没有热量，所有的食物都有热量。无糖食品用甜味剂取代蔗糖、果糖等作为添加剂，但是食物本身仍然含有较多的碳水化合物，只能少量品尝。

误区六: 只要控制糖和主食就是饮食治疗。

解答：饮食治疗关键是控制每日饮食总热量，需要科学安排摄入食物种类和数量，不仅仅只控制主食和糖的摄入。

三、糖尿病患者血糖监测

仔细阅读住院期间护士给您的疾病宣教单

<Table3>血糖监测目标

空腹(mmol/L) 3.9~7.2

非空腹(mmol/L) ≤10.0

糖化血红蛋白 (%) <7.0

(反复低血糖/年龄大/严重心血管疾病者，血糖控制目标可适当放宽)

<Table3>血糖监测目标

根据不同的患者个体状态，有不同的血糖监测目标。当患者在空腹状态下，血糖检测值在 3.9~7.2(mmol/L)范围内，非空腹状态下血糖检测值在≤10.0 (mmol/L) 范围内，糖化血红蛋白 (%) <7.0。注意：(反复低血糖/年龄大/严重心血管疾病者，血糖控制目标可适当放宽)。

血糖监测的意义

1.空腹血糖：可以反映头天晚上的用药是否可以控制血糖到次日晨(即降糖药的远期疗效)，还可以间接反映机体自身基础胰岛素的分泌情况；

2.午餐、晚餐前血糖：可用来指导患者调整进食量和餐前注射用胰岛素或口服药的量;

3.三餐后血糖：可以反映饮食控制和用药后的综合治疗效果，便于指导饮食

和药物治疗；还可以间接反映进餐刺激后胰岛素的分泌情况；

4.睡前血糖：反映胰岛β细胞对进食晚餐后高血糖的控制能力。监测睡前血糖主要是为了指导病人科学加餐。

血糖监测注意事项

1.正确保存试纸，请将试纸放于干燥的环境中，拿出试纸快速盖上瓶盖，并尽快使用完毕，关注试纸的有效期。

2.每次监测血糖之前请认真核对血糖仪代码和试纸代码是否吻合一致。

3.酒精消毒手待干后，方可进行监测。

4.滴血量应使试纸测试区完全浸润变色后方可开始监测。

5.采血针请一次性使用。

为什么测手指血糖只能用 75%酒精消毒？

因为碘是氧化剂，葡萄糖是还原剂，测血糖的试纸上含有的化学物质和含碘物质发生化学反应，而且碘伏消毒以后皮肤会有染色，血糖仪是利用试纸监测，血液和碘伏混合，必然会对监测结果有影响。因此，请务必用 75%酒精消毒待干后方可进行监测。

为什么监测手指血糖时不能用力挤压指尖？

患者在采血过程中过分按摩和用力挤压针扎部位，这时不仅会挤出血，还会挤出一部分皮肤的组织液，对血液标本造成稀释，使得血糖的测试结果偏低。

哪些因素可导致血糖波动？

生病、手术、外伤

错误的使用药物

情绪波动：生气、焦虑、抑郁等

日常饮食和运动不规律

睡眠障碍、旅行等

糖友出现以下九种情况赶紧测血糖

1.出现饥饿感 许多患者认为，有饥饿感就是低血糖。其实有些患者由于存在胰岛素抵抗，自身血糖很高但不能被身体利用，也会产生饥饿感。

2.口渴 口渴是高血糖的症状之一，因此在喝水前最好搞清楚，到底是因为血糖高还是因为体内缺水。

3.疲劳 血糖波动时，患者易感疲劳。所以，如果觉得全身没劲，应测一下血糖，采取相应措施。

4.开车 患者在血糖异常时开车是很危险的。如果血糖过低，可以先补充糖份，15 分钟后再检测，确认正常后再开车。如果血糖过高，最好请别人开车。

5.睡得特别沉 有些患者睡得特别沉，血糖高、低都不能使他们醒来。对这些患者来说，最好上床睡觉前测一次手指血糖，上闹钟，半夜起来再测一次。

6.脾气变大 低血糖的症状包括易怒、焦虑、颤抖、心慌、出汗、饥饿等，因此出现情绪变糟时，也许该测血糖了。

7.压力骤增、忙碌 家庭变故、工作压力或者忙碌会使血糖水平升高，因此应该提醒自己监测血糖。

8.锻炼 运动会使血糖短暂升高，接下来又能降低血糖。应该咨询医生，看看运动前可以接受的血糖是多少。锻炼时要把应急的甜食和手机、血糖仪带在身边。

四、糖尿病患者运动指导

仔细阅读住院期间护士给您的疾病宣教单

运动总原则

循序渐进、量力而行、持之以恒

糖尿病运动口诀

一、三、五、七、九”

“一”代表:餐后 1 小时运动;

“三”代表:运动 30 分钟;

“五”代表:每周至少活动 5 次;

“七”代表:每次运动中脉搏不超过 170—年龄;

“九”代表:运动要长久，持之以恒。

运动的适应症

病情稳定的 1 型糖尿病;

病情稳定的 2 型糖尿病;

病情稳定的妊娠期糖尿病。

运动的好处

精力充沛

减轻体重

控制血糖

改善情绪

运动的禁忌症

1 血糖>14~16mmol/L 或血糖波动较大；

2 明显的低血糖症；

3 合并各种急性感染；

4 合并糖尿病急性并发症；

5 严重的糖尿病慢性并发症:

6 伴有心功能不全、心律失常，且活动后加重；

7 新近发生的血栓；

8 高血压未被控制；

9 经常出现脑供血不足症状。

运动强度分类：

最低强度运动(约 30 分钟)：散步、做家务、打太极拳、开车购物。

低强度运动(约 20 分钟)：跳交谊舞、下楼梯运动、平地骑车、打桌球。

<Table4>一周运动计划举例

时间

早上

周一 太极拳，周二 慢跑，周三 无，周四 慢跑，周五 太极拳，周六 无，周日 剪花；

中午

周一 无，周二 无，周三 无，周四 无，周五 无，周六 购物，周日 无；

晚上

周一 散步，周二 散步，周三 散步，周四 无，周五 无，周六 无，周日 打羽毛球；

<Table4>一周运动计划举例

一周运动的计划，按照一天的早中晚进行划分，

周一的早上进行太极拳运动，中午暂停运动，晚上散步；

周二的早上 慢跑，中午暂停运动，晚上散步；

周三的早上 暂停运动，中午暂停运动，晚上散步；

周四的早上 慢跑，中午暂停运动，晚上暂停运动；

周五的早上 太极拳，中午暂停运动，晚上暂停运动；

周六的早上 暂停运动，中午购物，晚上暂停运动；

周日的早上 剪花，中午暂停运动，晚上打羽毛球。

中等强度运动(约锻炼 10 分钟)：平地慢跑、溜冰、做广播操、上楼梯运动、划船、打羽毛球。

高强度运动(约锻炼 5 分钟): 跳绳、游泳、举重、打篮球。

最佳运动强度的判断

周身发热、出汗，但不是大汗淋漓；或气喘吁吁，但能说话、不能唱歌。运动时保持脉率=170—年龄。

运动时段的选择

应该在餐后 30 分钟或 60 分钟或 90 分钟开始运动，避免空腹运动。

运动注意事项

(1)使用胰岛素的病友要特别注意运动前将胰岛素注射在腹部，不应注射在大腿和上肢，避免肢体活动使胰岛素吸收加快，作用加强，而诱发低血糖。

(2)注意监测一次运动后血糖。

(3)运动随身携带的物品

1 瓶水；

1 条毛巾；

1 袋饼干或 3-5 块糖果；

1 张急救卡。

急救卡

我是糖尿病患者，如果发现我行为出现异常或昏迷，可能发生了低血糖，请尽快将我衣袋中的糖块放入我口中，并按卡片背面所述地址和电话通知紧急联系人，同时尽快送我到医院紧急抢救，谢谢!

(4)运动衣物的准备

宽松的衣服；合脚的运动鞋；透气吸汗的棉袜。

(5)运动后注意检查双脚，查看有无红肿、青紫、水疱、血疱和感染等，及时发现脚部的问题。

(6)注意运动后的感觉，如果出现持续性疲劳、运动当日失眠、运动后持续性关节酸痛等不适，则表示运动量过大，下次运动时要适当减少运动量。

<Table5>糖尿病主要合并症运动处方简表

合并症

冠心病

糖尿病心肌病

高血压

闭塞性动脉硬化症

糖尿病合并慢性阻塞性肺病

强度

冠心病低

糖尿病心肌病低

高血压低、中

闭塞性动脉硬化症中

糖尿病合并慢性阻塞性肺病中

时间

冠心病低 ，20-45 分钟；

糖尿病心肌病低 ，20-45 分钟；

高血压低、中，≥30 分钟；

闭塞性动脉硬化症中，≥30 分钟；

糖尿病合并慢性阻塞性肺病中，≥30 分钟。

频率

冠心病低 ，20-45 分钟，3-4 次/周；

糖尿病心肌病低 ，20-45 分钟，3-4 次/周；

高血压低、中，≥30 分钟，>4 次/周；

闭塞性动脉硬化症中，≥30 分钟，每天一次；

糖尿病合并慢性阻塞性肺病中，≥30 分钟，2-5 次/周。

方式

冠心病低 ，20-45 分钟，3-4 次/周，慢跑、太极拳、步行、骑车等有氧训练；

糖尿病心肌病低 ，20-45 分钟，3-4 次/周，慢跑、太极拳、步行骑车等有氧训练；

高血压低、中，≥30 分钟，>4 次/周，静气功、有氧训练；

闭塞性动脉硬化症中，≥30 分钟，每天一次，上肢和躯干肌的运动锻炼；

糖尿病合并慢性阻塞性肺病中，≥30 分钟，2-5 次/周，有氧训练、抗阻训练。

<Table5>糖尿病主要合并症运动处方简表

不同的糖尿病合并症，对应不同的运动强度、运动时间、运动频率和推荐的运动方式。

冠心病，低 ，20-45 分钟，3-4 次/周，慢跑、太极拳、步行、骑车等有氧训练；

糖尿病心肌病，低 ，20-45 分钟，3-4 次/周，慢跑、太极拳、步行骑车等有氧训练；

高血压，低、中，≥30 分钟，>4 次/周，静气功、有氧训练；

闭塞性动脉硬化症，中，≥30 分钟，每天一次，上肢和躯干肌的运动锻炼；

糖尿病合并慢性阻塞性肺病，中，≥30 分钟，2-5 次/周，有氧训练、抗阻训练。

五、糖尿病患者心理护理

糖尿病患者心理护理篇

送给每位糖友的话

糖尿病除了使您的血糖升高或者降低，也会使您的情绪受到波动，如影随行，严重时还会进一步引发心理问题。所以我们要认识到：糖尿病是一个长期存在且不断变化，它不仅会影响您自己，还会影响与您共同生活的每一个人。因此，阳光般的心情、良好的心境和积极的应对心态，和谐的人际关系，有助于您保持健康的生活状态。

当得知自己患糖尿病后可能您会经历以下心理历程

1.拒绝 否认责备，怀疑诊断错误。

2.愤怒 为什么会发生在我身上（我亲人身上)?

3.恐惧 得了糖尿病，以前爱吃的食物都不能吃了，我的生活将不如从前。

4.抑郁 被各项严格的限制击垮，沮丧，无助无望感。

5.接受 接受糖尿病教育，治疗见效，心情豁然开朗。

不良情绪的反复发作会影响血糖的控制

糖尿病会因应激不良情绪导致恶性循环：焦虑 紧张 恐惧 激动—>血糖升高_—>并发症增多—>病情变化—>焦虑、抑郁恐惧、无助—>依从性差—>血糖控制差

如何自我识别“抑郁情绪”？

缺乏愉悦、失去兴趣、长期失眠、思维迟钝、自卑自责、脾气急暴、不愿交往、常感到空虚、对性生活无兴趣、常想到死亡。

如何及时处理抑郁情绪？

1.不必默默忍受，让医生了解您的需要，适当用药可以帮助您克服抑郁情绪。2.接受糖尿病，带着糖尿病一起生活，不让疾病左右自己的心情。

如何做才正确?

1.调适积极的心理状态

阳光心态是您健康生活的开始

2.乐观向上

既来之则安之、乐观平静、主动学习、主动就医、健康生活。

3.做情绪的主人

观察自己，并记录自己的情绪变化。觉察评估自己积极与消极的情绪，鼓励自己积极的思维，克制不良情绪。

4.感人的家庭力量

我成了家人的累赘•••

我们永远需要你，

我们会和你一起努力，

爸爸你真棒！我会像你积极面对糖尿病一样去积极面对困难！

您的担忧

担心自己成为家庭负担；

担心给整个家庭的生活带来不便。

要记住

您是家庭不可或缺的一员，家人永远需要您。您采取自信积极的态度，家人也会有积极自信的态度。

5.让他人了解您的需要，理解就是最大的支持

我正在测血糖

运动对血糖有好处，你们想了解吗?

您觉得

您的需要没有满足?

您觉得他们根本不知道您需要什么?

您可以

让周围的人明白您到底需要什么?

了解他人到底能给您提供什么帮助?

6.实现自我价值，不戴“糖友”帽子

信心的建立来源于日常生活；保持正常人际交往机会，享受生活乐趣；劳动量的付出有助于降低血糖、减轻体重，减轻个人、家庭的经济负担。

糖尿病患者两类工作不宜做

工作时间不规律，长期加班或上夜班。高空作业者、职业驾驶员。患有并发症时，不宜选择加重并发症的工作。

7.追求幸福，建立家庭

争取对方的理解和信任双方共同学习糖尿病知识健康生活方式创造美好新生。

学习与糖尿病和平共处

六、糖尿病患者胰岛素泵治疗

胰岛素泵使用须知

胰岛素泵是什么?

1.胰岛素泵又称胰岛素持续皮下注射泵(CSII)，它是人工智能控制的胰岛素输入装置，通过持续皮下输注胰岛素的方式，模拟胰岛素的生理性分泌模式，从而更好的控制血糖的一种胰岛素治疗方法。

2.胰岛素泵大小如手机，携带方便，它通过一根细细的输注管路持续向您的

体内输注胰岛素。

哪些患者需使用胰岛素皮下泵?

1.1 型糖尿病患者和需要长期胰岛素强化治疗的;2 型糖尿病患者住院期间。

2.需要短期胰岛素强化治疗的新诊断或已诊断的 2 型糖尿病患者。

3.妊娠期糖尿病、糖尿病合并妊娠及糖尿病患者孕前准备。

4.糖尿病患者的手术期血糖控制。

带泵患者有哪些注意事项

1.防摔、防丢失胰岛素泵为精密贵重仪器，请您在带泵期间妥善保管，避免遗失和摔坏，尤其在您入厕时，请妥善固定好胰岛素泵，以免掉入厕所。

2.防水由于胰岛素泵不具备防水功能，请您在洗澡之前找护士为您分离胰岛素泵。

3.防辐射 严禁携泵进入核磁共振室，CT 室，手术室，PET 中心，高压氧舱;在您进行以上检查前，请找护士为您取下胰岛素泵。

4.佩戴胰岛素泵期间，请您在每次吃饭前找护士为您调节餐前胰岛素。严禁带泵外出。

5.如出现低血糖症状(头昏、心慌出冷汗等)，请就地休息并呼叫护士为您测血糖。

6.如胰岛素泵出现震动或者任何声响请找护士检查您的泵是否有异常情况。

7.有任何不清楚的地方，请您及时与护士联系。

低血糖症状及处理

1.如您的血糖≤3.9mmo/l 时或出现了心慌、出冷汗、饥饿感等，您可能出现了低血糖;

2.出现低血糖时，请在医护人员指导下立即进食含糖的饮料或食物。

胰岛素泵常见误区

误区一: 腹部埋了一个针头，会严重影响我的日常活动吗?

A：佩带胰岛素泵不影响您的正常活动您无需担心运动或他人碰到您的皮下注射装置，这些装置在所有时间内都是无痛的。

误区二:胰岛素泵上好后它就在自动注射胰岛素，我还需要再找护士注射餐前大剂量吗?

A：需要。虽然胰岛素泵在自动输注小剂量的胰岛素，但是餐前需要护士在泵上进行人工操作，以控制餐后血糖。

误区三：胰岛素泵一旦开始用，以后就必须一直打胰岛素，会上瘾吗?

A:使用胰岛素不会上瘾。严来说胰岛素不是药，它是人体必须的降糖物质。需不需要继续使用胰岛素取决于病情。

胰岛素泵突发状况处理

1.胰岛素泵跌落:立即从地上拾起来并通知护士，及时让护士进行泵的检查

2.胰岛素泵进水:用清洁纸巾擦干表面水迹，立即到护士站向护士说明情况，将泵交给护士处理。

3.胰岛素泵报警:到护士站找护士，找出报警原因并解除报警。

七、糖尿病患者慢性并发症

仔细阅读住院期间护士给您的疾病宣教单

糖尿病有哪些慢性并发症?

糖尿病肾病

糖尿病足病

糖尿病视网膜病变

糖尿病脑病

糖尿病口腔病变

糖尿病神经病变

糖尿病心脏病

怎样预防糖尿病心脑血管疾病?

改变不良生活方式

科学饮食;

合理运动;

忌烟、忌酒;

限油及限烟，饮食清淡;

粗细粮巧搭配，蔬菜餐餐有;

少量多餐;

适量饮水。

控制高血糖:空腹血糖控制在 3.9~7.2mmol/L;

非空腹血糖≤10.0mmol/L。

血压、血脂达标:控制高血压，一般控制在 40/80mmHg 以下；纠正血脂紊乱。

定期监测体重、腰围、血糖、血压、血脂、心电图保持情绪稳定，调整心态，保持乐观、豁达、开朗的情绪。

如何预防及处理糖尿病肾病？

改变生活方式

低蛋白饮食(选择优质蛋白)如蛋类、牛奶、肉类等；

控制血糖;

控制血压;

纠正血脂紊乱;

减少蛋白尿;

透析治疗和肾移植。

如何预防糖尿病视网膜病变？

每年一次到医院进行眼底检查;

控制好血糖、血压;

改变不良的生活方式(控制高糖高脂饮食等);

运动时避免跳水、举重等活动；

注意用眼卫生，避免视疲劳；每日看电视、用电脑不超过 8 小时，经常眨眼；

眼底检查的项目：视力检查、眼底检查、眼底荧光造影、眼压测量。

如何预防糖尿病神经病变?

良好地控制血糖、纠正血脂异常、控制高血压；

诊断糖尿病后，至少每年 1 次糖尿病周围神经病变的检查；

病程较长或合并眼底病变、肾病等，应每隔 3~6 个月进行复查；

已经罹患周围神经病变者，做好足部的护理。

如何预防糖尿病下肢血管病变?

控制高血压;

纠正血脂异常;

应用阿司匹林治疗;

吸烟者必须戒烟；限制酒精摄入；

间歇性跛行者鼓励进行适当的运动锻炼。

如何识别引起糖尿病足的高危因素?

以往有过足溃疡或截肢的病史；

下肢的麻木、刺痛或疼痛，尤其是夜间疼痛；

间歇性跛行、静息痛；

皮肤暗红、温度降低、水肿、趾甲异常、溃疡等;

骨或关节畸形；

鞋袜不合适。

如何预防糖尿病足？

定期到医院检查，排除糖尿病足病的潜在危险；

向医生详细询问危险因素，充分认识潜在危险；

认真学习糖尿病足的防护知识，并让家人也一同学习，帮助自己更好预防糖尿病足的发生；

穿合适的鞋袜。

八、糖尿病患者胰岛素治疗

胰岛素注射患者该如何照顾自己

仔细阅读住院期间护士给您的疾病宣教单

胰岛素注射患者饮食

1.合理控制一日总热量(营养师推荐)，定时定量进餐。

2.睡前血糖低于 5.6mmol/l 时，睡前进食含 25g 碳水化合物食品如 4 块苏打饼干。

胰岛素注射患者运动：

1.血糖波动大或血糖 >14mmol/l 时，请停止运动。

2.血糖低于 5.6mmol/l 时，运动前进食含 25g 碳水化合物食品如 4 块苏打饼干。

3.运动时应避免注射胰岛素部位的肢体过度活动。

胰岛素注射患者血糖监测：

1.使用胰岛素治疗的患者，每日至少自我监测血糖 5 次，达到医生设定目标后可每天监测 2~4 次。

2.如您的血糖控制较差或波动大时，应每日监测 4~7 次，直至血糖平稳。

低血糖症状及处理 ：

1.如您的血糖<3.9mmol/l 时或出现了心慌、出冷汗、饥饿感等，您可能出现了低血糖 ；

2.出现低血糖时，应立即进食含糖的饮料或食物，如有条件可先检测血糖，随后吃含“15g”的葡萄糖饮料或食物如 2~5 个葡萄糖片、半杯桔子汁、两大块方糖、一大汤勺的蜂蜜等，15 分钟后您需再次测量血糖，如果血糖<4m mmol/l 时 ，您还需吃“15g”的葡萄糖饮料或食物。

3.如您的低血糖发生在午夜或离下一餐还有 1 小时，还需吃含“25g”的碳水化合物的食品。

胰岛素保存 ：

1.未使用的胰岛素应放置于 2°C~8°C 的冰箱冷藏室，并且靠近冰箱门的位置保存

2.正在使用的胰岛素在一般室温下（20C 左右，不超过 25°C~30°C）保存 30 日。

胰岛素注射针头 ：

一次性使用胰岛素注射笔用针头

胰岛素注射患者旅游技巧 ：

1.出发前 4 周去医院看病征求医生的意见。

2.准备足量的胰岛素及用具，如您将要坐飞机旅行，可随声携带胰岛素笔芯 3 支（严禁托运）

3.随身携带糖尿病保健卡及一些简单的含糖食品。

您的血糖控制目标（由您的医生填写）

空腹：_____mmol/l

餐后：_____mmol/l

胰岛素注射部位轮换图 ：

注射部位包括腹部、大腿外侧\臀部外上侧以及上臂外侧.

胰岛素注射部位轮换:

不同注射部位间轮换。注射部位的左右轮换。同一注射部位的区域轮换

注射点与注射点之间，距离不小于 1 厘米

血糖监测记录的注意事项

详实血糖监测记录有利于帮助医生整您的降糖治疗方案，请您每次就医时一定要携带血糖监测记录本。血糖监测记录本需记录:

1.测血糖日期、时间；

2.与进餐、运动、药物的关系；

3.低血糖的时间、频率:

4.生病情况；

5.连贯的记录。

请携带您的血糖监测记录本，并于_____去门诊 3 楼复诊就医。就医时请带上门诊病历、出院记录。